Revised: 2022/08

兒童感染科 Orientation

白班工作內容

- ✓ 本科目前病房主治醫師：黃玉成教授，邱政洵教授，謝育嘉主任，陳志榮醫師，郭貞孍醫師，黃冠穎醫師。
- ✓ 上班時間為 7:00 至 16:30，各主治醫師均於 meeting 完查房。**請在主治醫師查房前看完病人 data 並幫病人做完應做之身體理學檢查(PE)，尤其時前一天的 new patient 請務必在查房前先看過病人做完 PE。**
- ✓ 查完房請優先開立出院醫囑，**若在 10:00 當日出院醫囑來不及開立可請總醫師先幫忙開立 Discharge order**。情況穩定預計出院之病人可詢問主治醫師是否開立今辦明結。
- ✓ 若遇病人狀況不穩定(Shock, vital sign abnormal, conscious change, respiratory failure 等)，務必優先處理並向上跟總醫師反應。處理完病人也請務必追蹤異常 vital signs 是否都有改善，**並和晚上值班醫師交班**。若病人需轉加護病房，請聯絡主治醫師並請總醫師要床; 轉送病人至 PICU 後請完成 transfer note 並和加護病房醫師交班。
- ✓ 若有特休請特休前一天詢問總醫師之後的工作要交接給誰並打完 off service note，再和交接的住院醫師交班。
- ✓ 白班新病人：(看完新病人有任何問題都應該找上級的總醫師一起討論)
  - ■ 每個 team 第一床新病人由當 team 醫師自己接，第二床以後請聯絡當月負責之總醫師，由總醫師分配住院醫師接病人。
  - ■ 門診住院之病人請先**看住院單上是否有主治醫師交代的 order。**
  - ■ 急診住院病人請務必**自己重新評估做 assessment，確立診斷。**
- ✓ 若值班隔天 pm / day off，以下狀況**請和代理人交班**：
  - ■ 有未出來檢驗/檢查報告需要看 data 或病人要去做特殊檢查(e.g. MRI, CT, aspiration…)
  - ■ 病人診斷尚未明確或有新的異常狀況
  - ■ 有需特別注意溝通之家屬

科內例行活動

- ✓ Journal reading: **每週三 11:00 – 12:00 於 12L 討論室**，選讀 2-4 篇 SCI 論文。每週會請 1-2 位 PGY, R 輪流準備。報告時間為 15-20 分鐘(嚴格執行，不可超過 20 分鐘!)，請準備 ppt 一同報告。
- ✓ Morning meeting: **每週四 07:30 於 11L 討論室**，討論過去一週科內或會診看到的特殊案例，會請負責 primary care 的醫師口頭報告病史，內容請製作於記事本或 On duty note，若有照片請放在桌面或 PPT。
- ✓ 每週不定時會有黃玉成教授的 bedside teaching，時間與地點另以簡訊通知。
- ✓ 有外賓或廠商演講會另行以簡訊通知，請一同出席。

Revised: 2022/08

病歷書寫

- ✓ 病歷書寫請按照兒童內科部病歷書寫規定，**請於病人出院 72 小時內完成該病人之出院病摘**。每個禮拜一請注意假日病人出院未完成病歷並儘早補完。
- ✓ Admission note:
  - ■ 兒童感染科 => 病歷範本 => **請依據病人狀況自行做增減**
  - ■ Vaccination history 請務必詢問自費疫苗施打情形，**並請家屬攜帶健兒手冊來做追蹤**。
  - ■ Physical examination 以及 Review of system 若有異常請用" ** "做註記
  - ■ 診斷請盡量用**明確的診斷**(e.g. community acquired pneumonia, right upper lobe, suspected mycoplasma infection)並避免單一診斷。
  - ■ 檢驗報告請適當判讀。
- ✓ Progress note:
  - ■ Subjective 每天應詳實記載病人主觀症狀的改變
  - ■ Objective 可記載重點 physical examination 並描述變化，並附上新出來的檢驗/檢查報告
  - ■ Assessment 的診斷請以主治醫師查完房給的診斷，並每日更新病情狀況(improved/stationary/worsened/inactive)
  - ■ Plan 請註記重要藥物的劑量以及使用時間(e.g. augmentin 120mg/kg/day 7/1-7/4)

醫囑開立注意事項

- ✓ 重要藥物(**抗生素，類固醇，anti-epileptic medication**)**請在藥囑後方註記劑量 (xx mg/kg/day)**，不常開立之抗生素請先和主治醫師或總醫師確認使用劑量。
- ✓ 開立診斷書請僅需註記門診，急診及住院時間，並用電子簽章。
- ✓ 開立特殊檢查(任何超音波/電腦斷層/血液抹片)請**註記 indication**
  - ■ 疑似川崎氏症的**心臟超音波務必註記身高，體重，年紀。**
  - ■ **開立腦部超音波，若需要看腦壓，請註記 r/o IICP 或 請加量腦壓**
- ✓ 病人若無法配合檢查，請開立口服 chloral hydrate 鎮定劑 (自費 200 NTD)
  - ■ 劑量：0.5ml/kg/dose，若是心臟超音波請開 0.6ml/kg/dose，max 20ml。
  - ■ MRI 檢查之病人可與總醫師討論是否開立全量，或加 midazolam。

  功能選單→病歷記載→同意書→同意書開立→麻醉科
  - ■ 需要 **Chloral hydrate 同意書**。鎮靜恢復表請在同意書系統中填完
  - ■ 若需要 Midazolam 鎮定，則需要**中重度鎮定同意書**。鎮靜恢復表請在同意書系統中填完
- ✓ 呼吸道感染，survey pathogen: 視情況開立 Filmarray (檢體別 TH) **L72-971** (自費 8000 元)或 Viral isolation (檢體別 TH) or 手寫醫囑" virus isolation(送合約實驗室)"，並填寫合約實驗室紅單送檢。
- ✓ 腸病毒住院之病人請注意是否有重症警訊，**不要過度 hydration (daily maintenance 80% IV fluid 即可)**。**疑似重症之個案需規則監測血壓，血糖以及心跳。**
- ✓ 呼吸道感染病人住院請注意呼吸次數以及是否有呼吸窘迫之徵象，若喘應監測血氧。